Control del brote prioritario de IAAS por A. baumannii complex MDR en UCIA del HAEV

3 mensajes

Alejandra De Jesús Cortés Ramírez <alejandra.cortes@imssbienestar.gob.mx> jue, 8 de oct de 2026 a la hora 12:09 p.m.
Para: UVEH HAEV <uvehaev@gmail.com>

Correo No. CE-IBVER/JSAS/JDEPI/COM/0015/2026
Asunto: Seguimiento y acciones de Control del brote prioritario de IAAS por A. baumannii complex MDR en UCIA del HAEV.

Dra. Claudia Caloca
Encargada de la UVEH del HAEV
P r e s e n t e

Por instrucciones del Dr. José Misael Hernández Carrillo, Titular de la Coordinación de Epidemiología y de la Dra. Zaira Lastra Jiménez, Titular de la División de Prevención y Control de Infecciones, hago de su conocimiento que, con relación al **brote de IAAS por *A. baumannii complex* MDR en la UCIA del HAEV**, notificado en la plataforma NOTINMED el día 21/08/2026 y 23/09/2026, correspondientes a la notificación **inicial folio NM00392057-0 y de cierre con folio NM00392057-1,** el cual cumplió características para considerarlo como **BROTE PRIORITARIO** (por ser microorganismos prioritarios para la OMS).

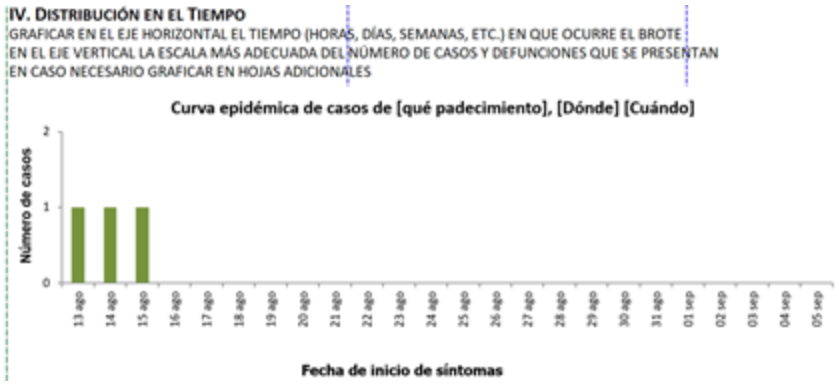
A continuación, compartimos con usted algunas observaciones , las cuales le pedimos sean consideradas como una retroalimentación con la finalidad de mejorar la calidad e integridad de la información con el objetivo de que se pueda realizar el análisis de los datos para implementar acciones adecuadas de control, así mismo a algunas observaciones se debe dar eguimiento a la solicitud de información complementaria, la cual deberá ser integrada según corresponda a la plataforma de SEVEIAAS, resguardada como evidencia documental al nivel estatal y en algunos otros casos será de utilidad para que usted y el hospital documenten de manera adecuada el despliegue realizado para el estudio y el eventual control del brote en comento:

REGISTRO SUIVE-3

1. Apartado **II. Antecedentes**, **agregar el tipo de IAAS del brote** en la variable DX probable y DX Final una vez que los casos sean validados (así como en el censo de casos).
2. **Validación de los casos**, corroborar que los casos cumplan con los criterios de clasificación de IAAS de acuerdo con el Manual vigente de Procesos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS de la RHOVE, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/920660/Manual_de_procedimientos_estandarizados_para_la_vigilancia_epidemiol_gica_de_las_IAAS_-_RHOVE_junio_2024.pdf

   NOTA: Para determinar que se trata de un caso de IAAS, el caso deberá cumplir criterios clínicos, en algunos casos como en NAAS con criterios de imagen y la identificación del agente, asociado a un factor de riesgo; siguiendo dichos criterios, es necesario que se realice la validación; por ejemplo, en los casos de NAV (2 casos), se identifica en los registros de SEVEIAAS que a ambos les retiraron la VM el 12/08/2026 y realizaron una traqueostomía (11 y 12 agosto 2026) con fechas de inicio de síntomas 17 y 20 de agosto, lo cual representa 6 y 8 días después de la traqueostomía y del retiro de la VM, además, a uno de los casos se le instaló una sonda pleural el 02/08/2026; por lo anterior **¿hay posibilidad que alguno de los casos pueda clasificarse como NAAS relacionada algún procedimiento o se descartaron criterios de ISQ (en caso de que la traqueostomía se realizará en quirófano, dato que no está registrado en SEVEIAAS)?**
3. Apartado **IV. Distribución en el tiempo**, la curva epidémica debe realizarse con la fecha de inicio de síntomas y no con la de toma de muestra; como unidad centinela RHOVE es importante que la información que se registre en NOTINMED como en SEVEIAAS sea congruente; ya que, las fechas de inicio de síntomas y de toma de cultivo son diferentes en ambos sistemas; deberá realizarse la validación de los casos para clasificarlos de acuerdo con el tipo de IAAS y actualizar la información en ambas plataformas (**Imagen 1**).

Imagen 1. Curva Epidémica

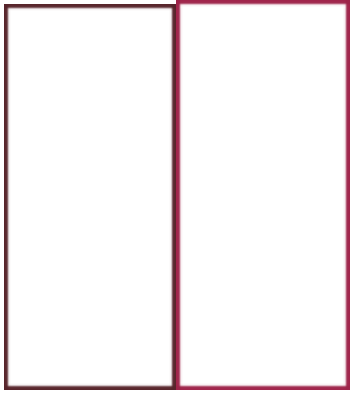


Por ejemplo: el caso A.J.G.V en **SEVEIAAS** se registro como inicio de síntomas y toma de cultivo del **20/08/2026;** mientras que en el **SUIVE-3** tiene fecha de inicio de síntomas y toma de cultivo el **13/08/2026.**

4. En el apartado **VI. Análisis epidemiológico, subapartado Antecedentes,** agregar la descripción del panorama epidemiológico de IAAS en el servicio afectado (tipos y frecuencia de las IAAS, microorganismos identificados en estas IAAS, letalidad, resistencia antimicrobiana); en caso de tener antecedente de un brote con características similares, deberá agregarlo en este apartado (identificamos que en mayo 2026 se presentó un brote con características similares; será importante analizar si podrían estar vinculados o provenir de la misma fuente), indagar si en otros servicios existen IAAS por el microorganismo identificado en el brote.
5. En el apartado de **Acciones de Control**, agregar las fechas en las que se fueron realizando las acciones de contención y aquellas que son específicas de acuerdo con la **hipótesis sobre el probable origen de la transmisión,** ya sea, personal sanitario, pacientes, visitantes, superficies, ambiente, suministros, dispositivos médicos o equipos que albergan al microorganismo o agente causal, describa a mayor detalle que procedimientos y/o dispositivos son probable **asociación entre los casos**.
6. **Agregar al censo nominal todos los factores de riesgo que los casos tuvieron desde su llegada hasta el inicio de síntomas:** fechas y servicio de ingreso al hospital, fecha y servicio a los que fueron trasladados, fechas y servicios en los que se les haya realizado algún procedimiento (sea quirúrgico o no quirúrgico; por ejemplo curaciones), fechas y servicios en los que se les instaló un dispositivo invasivo y retiro (ventilación mecánica, catéter urinario, catéter central, catéter periférico, etc.), de considerarlo necesario, agregar el personal que realizó el procedimiento o instaló el invasivo; tipo de muestra (en esta variable debe registrar si es hemocultivo central, periférico, ambos, aspirado bronquial, etc.), incluir para los casos de NAAS si el servicio de inhaloterapia realizó algún procedimiento; incluir el tratamiento antimicrobiano que se instauró para la IAAS.

   Asimismo, verificar la correlación de las variables del censo y la información contenida en este, ya que, por ejemplo, en fecha de inicio se colocaron signos y síntomas, sin especificar fecha (**Imagen 2**).

   Imagen 2. Llenado del censo de brote de IAAS en el SUIVE-3



EDAD (Años) < 1 año(Meses)	FECHA DE INICIO	FECHA DE ATENCIÓN MÉDICA	FECHA DE TOMA DE CULTIVO	TIPO DE MUESTRA	
29	Fiebre. Expectoración purulenta.	04/08/2026 (ingreso a UCIA)	13/08/2026	Secreción bronquial	
19	Fiebre.	07/08/2026 (ingreso a UCIA)	15/08/2026	Catéter	
39	Fiebre. Expectoración purulenta.	03/08/2026 (ingreso a UCIA)	16/08/2026	Secreción bronquial	

REGISTRO EN SEVEIAAS

1. Uno de los casos no esta identificado como parte del brote, se debe **agregar en la variable es parte de un brote "SÍ" y el folio NOTINMED.**
2. **Corroborar las fechas de inicio de síntomas y de toma de cultivo**, realizar el cambio en plataforma en caso de requerirlo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

· Compartir la **minuta de sesión extraordinaria del CODECIAAS** respecto al brote de IAAS por *A. baumannii complex (enviar la evidencia de acuerdos y compromisos).*
· Compartir la minuta o documento en el que quedaron plasmados los **riesgos identificados** mencionados en las acciones de control durante el **recorrido** que se realizó en el área.
· Compartir los resultados de la **identificación del microorganismo y resultado de las pruebas de susceptibilidad.**
· Compartir evidencia del **reforzamiento** del uso de EPP en precauciones estándar y de contacto, higiene de manos y desinfección de superficies de alto contacto (equipo médico) en el servicio afectado (listas de asistencia)
· Compartir cuáles fueron las **medidas que se reforzaron para el manejo y cuidado de dispositivos invasivos**, incluyendo ventilación mecánica, catéter venoso central y urinario.

Aprovecho la oportunidad para realizar el atento recordatorio que de **manera semanal y hasta el cierre** de los brotes de IAAS deberán **registrarse en *NOTINMED las actualizaciones conducentes,*** una *nota informativa* con el seguimiento puntual al estado de salud de los casos y a las acciones específicas de control cuando no se identifiquen nuevos casos o defunciones. De **identificar nuevos casos, defunciones o CIERRE** será necesario registrar el SUIVE-3 con la actualización de todos los apartados.

Adjunto encontrará los **SUIVE-3** registrados en la notificación inicial y de cierre, así como la **información de SEVEIAAS** (descarga 08/09/2026) sobre los casos de IAAS en el servicio de Terapia Intensiva de Adultos de la unidad para su pronta consulta.

Sin otro particular, quedo atenta a su respuesta.

Saludos cordiales,

Gobierno de México | IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD



2026 año de Margarita Maza

Dra. Alejandra de Jesús Cortés Ramírez
Jefa del Departamento de Epidemiología

Cerrada de Tapachula 6, Col. Badillo, C.P. 91045
Xalapa, Veracruz
Tel: 01 (55) 91608100 Ext. 323011
Cel: (228) 304 2646

Coordinación Estatal Veracruz
Jefatura de Servicios de Atención a la Salud
Departamento de Epidemiología

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, el IMSS-BIENESTAR tendrá derecho a ejercer acción penal, civil y/o cualquier otra en los términos de ley en base a los daños y perjuicios que esto le cause.

3 archivos adjuntos

- **CIERRE Brote HAEV UCIA baumannii 07092026.xlsx**
  253 KB
- **NM00392057-0_INICIAL_ITS A. baumannii_HAE_VERACRUZ.xlsx**
  188 KB
- **Casos de IAAS en UCIA del HAE Veracruz_080926.xlsx**
  90 KB

UVEH HAEV <uvehaev@gmail.com> jue, 8 de oct de 2026 a la hora 5:29 p.m.
Para: Alejandra De Jesús Cortés Ramírez <alejandra.cortes@imssbienestar.gob.mx>

RECIBIDO DRA, SE REALIZARÁN LOS CAMBIOS SOLICITADOS Y EL ENVÍO DE LA EVIDENCIA REQUERIDA; MUCHAS GRACIAS.
[Texto citado oculto]
--

Dra Claudia Cruz Caloca
Encargada de la
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria - UVEH
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz HAEV- Servicios de Salud de Veracruz
Avenida 20 de Noviembre #1074 Col. Centro
Teléfono: 01 (229) 9312663
Correo electrónico: uvehaev@gmail.com

UVEH HAEV <uvehaev@gmail.com> vie, 16 de oct de 2026 a la hora 2:20 p.m.
Para: Alejandra De Jesús Cortés Ramírez <alejandra.cortes@imssbienestar.gob.mx>

Por medio del presente, comparto el informe preliminar correspondiente al brote por ***Acinetobacter baumannii complex,*** notificado el pasado 21 de agosto del presente año, para su revisión.

Al respecto, informo que se encuentra pendiente la revisión de un expediente clínico, necesario para completar algunos de los datos solicitados. Asimismo, se requiere conciliar las variables que presentan inconsistencias entre los estudios de caso y el formato de notificación de brote, a fin de confirmar la clasificación de las IAAS y, en su caso, gestionar las correcciones correspondientes mediante los formatos establecidos para solicitud de cambios en plataforma RhOVE.

Una vez concluida la revisión, se integrará y remitirá el informe final con la información validada.

Saludos cordiales.

brote ucia-20261016T201314Z-1-001.zip

[Texto citado oculto]